梅毒定性検査にて非特異反応を認めた一症例

◎伊藤 桃佳[1)]、小林 茉穂[1)]、林 美月[1)]、原田 康夫[1)]、舟橋 恵二[1)]、井口 光孝[2)]
JA 愛知厚生連 江南厚生病院[1)]、JA 愛知厚生連 江南厚生病院 感染症内科[2)]

【はじめに】 当院では、RPR、TPAb 定性検査はラテックス凝集免疫比濁(LATIA)法による非トリポネーマ脂質抗体キット「メディエース RPR (積水メディカル株式会社)」およびトレポネーマ抗体キット「メディエース® TPLA (積水メディカル株式会社)」を用い、自動分析装置「TBA-FX8 (キヤノンメディカル株式会社)」で測定を行っている。今回、TPAb 定性検査に関して LATIA 法と化学発光酵素免疫測定(CLEIA)法で測定した結果が乖離した症例を経験したため報告する。

【症例】 20 代女性。20XX 年 5 月、発疹を伴う発熱を主訴に当院を紹介受診した。頸部リンパ節腫大と軽度の肝障害を認め、血液像(自動機械法)では異型リンパ球の出現が示唆された。ウイルス感染症疑いで追加検査を行い、HSV、CMV、EBV が既感染を示す結果であったが、RPR 陽性(3.3 R.U.)、TPAb 陽性(709.5 T.U.)と梅毒陽性を示す結果となり精査を実施した。RPR は炭末凝集法「RPR テスト 三光(積水メディカル)」にて実施し結果は陰性、TPAb は特異性を検証するため中和試験を実施し中和率 80.7%と陽性を示す結果となった。 2 週間後の再検査にて、RPR 陰性(0.0 R.U.)、TPAb 陽性(36.5 T.U.)と抗体価の著減を認めた。感染症内科と協議し、非特異反応を視野に TPAb について他法(CLEIA 法)にて確認検査を実施することとした。試薬および機器は「ルミパルスプレスト TP、ルミパルス L2400(富士レビオ)」を用い、結果は陰性(0.1 C.O.I)となった。過去の病歴ならびに臨床経過を含め、LATIA 法における TPAb 偽陽性が強く疑われた。

【考察】 両法の乖離は、試薬中の抗原組成や反応過程の相違に伴う非特異反応が要因として挙げられる。本症例では、短期間にて TPAb 値が著減したことから、ウイルス感染を契機に一過性に産生された交差反応性抗体による偽陽性である可能性が高いと考えられる。若年層における梅毒感染が急増する昨今、スクリーニング検査における偽陽性リスクを熟知し、臨床側との綿密な情報共有と検証を通じて、適切な検査結果を提供していくことが重要である。

連絡先：0587-51-3333（内線：2359）